ROZDZIAŁ 10

Hormony, leki i etapy życia

Seks nie „wyrównuje hormonów”. To hormony, zdrowie, leki i kontekst mogą zmieniać seksualność - a wiele problemów da się ocenić i leczyć.

> **MOCNE** Wytyczne kliniczne i przeglądy potwierdzają wieloczynnikowy charakter problemów seksualnych oraz rolę menopauzy, chorób i leków. [19] [20] [21]

Krótkie reakcje to nie trwała regulacja

Podniecenie i orgazm wiążą się z przejściowymi zmianami neurochemicznymi. Nie ma jednak podstaw do twierdzenia, że regularny seks stabilizuje testosteron, estrogeny, progesteron, tarczycę albo cały „układ hormonalny”. Gdy objawy sugerują zaburzenie hormonalne, potrzebna jest diagnostyka, a nie zwiększanie częstotliwości zbliżeń.

Menopauza i komfort

Spadek estrogenów może sprzyjać suchości, podrażnieniu i bólowi. ACOG opisuje te objawy jako częste i możliwe do leczenia. Przegląd Cochrane wskazuje, że estrogen może nieznacznie poprawiać funkcję seksualną u części kobiet z objawami menopauzalnymi, ale wyniki zależą od grupy i terapii. Decyzję podejmuje się indywidualnie z lekarzem. [19] [23]

Leki i choroby

Depresja sama może wpływać na pożądanie i funkcje seksualne, a leki przeciwdepresyjne - zwłaszcza SSRI - mogą zwiększać ryzyko trudności z orgazmem i obniżać satysfakcję. Nowa metaanaliza ocenia pewność części tych danych jako umiarkowaną lub wysoką. Nie odstawiaj leków samodzielnie; zgłoś działania niepożądane lekarzowi. [21]

Ból, suchość, problemy z pobudzeniem, orgazmem lub pożądaniem mogą mieć przyczyny biologiczne, psychologiczne, relacyjne i kulturowe. ACOG podkreśla znaczenie osobistego cierpienia i celów pacjentki w ocenie problemu - sama odmienność od statystycznej normy nie wystarcza do diagnozy. [20]

Ciąża i okres po porodzie

W prawidłowo przebiegającej ciąży większość aktywności seksualnych jest bezpieczna, o ile osoba ciężarna ma na nie ochotę i lekarz nie zalecił ograniczeń. Krwawienie, odpływanie płynu, ból lub określone powikłania wymagają konsultacji. Po porodzie powrót zależy od gojenia, zmęczenia, hormonów, bólu i gotowości - nie od kalendarzowego obowiązku. [22]

LISTA DO KONSULTACJI

Zapisz: od kiedy trwa zmiana, czy dotyczy ochoty, pobudzenia, orgazmu lub bólu; jakie leki i suplementy przyjmujesz; czy objaw zaczął się po zmianie dawki, chorobie, porodzie lub menopauzie; jak duże powoduje cierpienie. Taka lista ułatwia rzeczową rozmowę.

MIT

„Więcej seksu naturalnie wyrówna hormony.”

CO WIEMY

Nie ma takiej ogólnej terapii. Seks może dawać przyjemność i chwilowe reakcje fizjologiczne, ale zaburzenia hormonalne i działania leków wymagają osobnej oceny.

Źródła do rozdziału

[19] Lara LA i wsp. Hormone therapy for sexual function in perimenopausal and postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2023. Otwórz źródło

[20] American College of Obstetricians and Gynecologists. Female Sexual Dysfunction: Practice Bulletin No. 213. Obstetrics & Gynecology. 2019;134(1):e1-e18. Otwórz źródło

[21] Ferraz SD i wsp. Sexual dysfunction associated with selective serotonin reuptake inhibitors in adults with depression: systematic review and meta-analysis. 2026. Otwórz źródło

[22] American College of Obstetricians and Gynecologists. Is it safe to have sex during pregnancy? Informacja dla pacjentek. Otwórz źródło

[23] American College of Obstetricians and Gynecologists. The Menopause Years: objawy, suchość, ból i możliwości leczenia. Otwórz źródło